第十三章 消瘦的全科医学处理

本章数字资源

学习提要

本章介绍了消瘦的定义及其产生因素，从全科医师的角度，通过主观资料（S）、客观资料（O）、初步评估（A）和处置计划（P）等模块对消瘦临床案例进行剖析和解读，并对消瘦患者病史采集、病例特点、疾病鉴别、体格检查、辅助检查、基层评估与处置、转诊指征、健康教育等全科医学处理思路进行了描述。

消瘦（weight loss）是指体重低于标准体重 10% 或者体重与身高比例过低。现认为短时间内较大程度的体重丢失也是一种消瘦，即在过去 6~12 个月内体重下降超过原体重的 5%。目前国内外多采用体重指数（BMI）作为判定消瘦的标准，BMI<18.5kg/m^2 为消瘦。消瘦可由生理性原因所致，也可由病理性原因所致，全科医生接诊消瘦患者时必须充分了解病史，认真进行体格检查，完成必要的辅助检查，甚至进行有创性的检查，经综合分析后作出诊断。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，65 岁，因“消瘦 7 个月”就诊于全科门诊。

【问题 1】作为一名全科医师，接诊以消瘦为主诉的患者应如何采集病史？

思路 1：接诊以“消瘦”为主诉的患者，应首先了解消瘦者年龄、性别，以及体重多长时间内下降了多少。不同性别与不同年龄阶段，引起消瘦的原因不同。婴幼儿多是由喂养不当所致的营养物质摄入不足，或者慢性腹泻造成的营养物质吸收障碍；青年女性多须注意甲状腺疾病和神经性厌食；中老年须注意恶性肿瘤和慢性疾病如炎症性肠病、糖尿病等；多长时间内体重下降多少，有助于明确是否为消瘦。

思路 2：有无诱因：有无进食、劳动量、运动量的改变，有无药物服用史等。如了解平素营养摄入、进食总量、饮食结构，有助于判断消瘦是否与饮食情况有关；了解劳动量、运动量有助于判断是否为生理性消瘦；了解患者是否有服用二甲双胍史，部分服用二甲双胍的患者可出现消瘦。

思路 3：消瘦的起病时间和速度：起病急骤多见于恶性肿瘤或严重感染；起病缓慢多见于一些慢性疾病。

思路 4：消瘦的伴随症状对疾病的诊断和判断病情轻重十分重要。消瘦伴食欲亢进，多见于糖尿病和甲状腺功能亢进症；消瘦伴食欲减退，多见于严重感染、恶性肿瘤、神经性厌食症、希恩综合征或慢性肾上腺皮质功能减退症等；消瘦伴吞咽困难，可见于口、咽和食管疾病；消瘦伴上腹部不适，可见于慢性胃炎、胃溃疡、胃癌、胆囊或胰腺等疾病；消瘦伴下腹部不适，可见于慢性肠炎、肠结核、肠道肿瘤、慢性痢疾等；消瘦伴上腹痛、呕血，可见于溃疡病或胃癌等；消瘦伴便血，可见于炎症性肠病、胃癌、肝硬化等；消瘦伴咯血，可见于肺结核、肺癌等；消瘦伴黄疸，可见于肝、胆、胰等疾病；消瘦伴腹泻，多见于炎症性肠病、甲状腺功能亢进症、吸收不良综合征或慢性胰腺炎等；消瘦伴发热，多见于严重的感染性疾病或某些恶性肿瘤，如淋巴瘤等；消瘦伴多饮、多食、多尿，见于糖尿病；消瘦伴怕热、多汗、心悸、震颤，见于甲状腺功能亢进症；消瘦伴皮肤黏膜色素沉着、低血压，见于肾上腺皮质功能减退症；消

瘦伴神经症状，可见于精神紧张、长期失眠、焦虑、抑郁等。

思路5：发病以来的一般情况，除饮食、体重变化，精神、睡眠、大小便情况以及家庭支持情况，均需要进一步了解。

思路6：须了解患者的诊断、治疗与护理的经过。患者接受过什么诊断性检查，结果如何；是否服用过药物，药物的名称、剂量，效果如何，有无不良反应等。

临床上，消瘦病因较为复杂，机制不尽相同，需要全科医师详细问诊后进一步明确。因此，全科医师应熟练掌握消瘦的相关理论知识及诊治方法。

知识点

消瘦的分类

一、消瘦按发病机制分为四种：营养物质摄入不足、营养物质消化和/或吸收障碍、营养物质利用障碍、营养物质消耗增加等。

（一）营养物质摄入不足

1. 进食减少

（1）慢性感染性疾病：见于慢性严重感染。

（2）肾脏疾病：见于慢性肾衰竭。

（3）循环系统疾病：见于心功能不全。

（4）呼吸系统疾病：见于肺功能不全。

（5）消化系统疾病：可见于肝硬化、胆囊炎、胰腺炎、慢性萎缩性胃炎以及糖尿病性胃轻瘫等。

（6）神经精神疾病：可见于抑郁症、反应性精神病、神经性厌食等。

2. 吞咽困难

（1）口腔疾病：可见于咽后壁脓肿、急性扁桃体炎、舌癌、口腔炎等。

（2）食管、贲门疾病：食管损伤、食管癌、贲门癌等。

（3）神经肌肉疾病：重症肌无力、延髓麻痹等。

（二）营养物质消化和/或吸收障碍

1. 胃源性　可见于胃溃疡、重症胃炎、胃切除术后、胃泌素瘤、倾倒综合征等。

2. 肠源性　可见于各种肠道疾病、蔗糖酶缺乏症、先天性乳糖缺乏症及短肠综合征等。

3. 肝源性　可见于肝癌、肝硬化、重症肝炎等。

4. 胰源性　可见于胰腺大部切除术后、胰瘘、胰腺癌及慢性胰腺炎等。

5. 胆源性　可见于胆囊癌、胆囊切除术后、慢性胆囊炎、胆道功能障碍综合征、原发性胆汁性肝硬化及肝胆管癌等。

（三）营养物质利用障碍

糖尿病患者，因胰岛素缺乏，机体吸收的糖不能被体内细胞所利用，从尿中排出而引起消瘦。

（四）营养物质消耗增加

1. 内分泌代谢性疾病　可见于1型糖尿病、甲状腺功能亢进症等。

2. 慢性消耗性疾病　可见于重症结核或某些慢性感染、肿瘤等。

3. 大面积烧伤　烧伤可引起大量血浆从创面渗出，出现负氮平衡而导致消瘦。

4. 高热　体温升高可引起营养物质代谢率增高，加之患者食欲差，可引起体重下降。

二、消瘦按原因分为两类，即单纯性消瘦与继发性消瘦。

（一）单纯性消瘦

单纯性消瘦分为体质性消瘦和外源性消瘦。体质性消瘦可有家族史，生来即消瘦，无任何疾病征象；外源性消瘦是受饮食、生活习惯等因素影响所致的消瘦，经休息、补充营养后体重可很快恢复至原水平。如生长发育过程、劳动量或运动量过大、节食等均可导致单纯性消瘦。

（二）继发性消瘦

短时间内出现的不明原因消瘦，且伴乏力、食欲减退等不适，经休息后体重仍不能恢复至原水平，则可能是病理性消瘦。继发性消瘦均为病理性消瘦，按常见病因分类具体如下。

1. 感染性疾病　各种急慢性感染如感染性心内膜炎、结核、慢性阻塞性肺疾病、败血症、获得性免疫缺陷综合征、骨髓炎、寄生虫感染等。

2. 非感染性疾病　各系统慢性疾病及药物所致的消瘦，具体如下。

（1）内分泌系统：如糖尿病、甲状腺功能亢进症、垂体功能减退。

（2）消化系统：如炎症性肠病、肠易激综合征。

（3）心血管系统：如心肌病、慢性心力衰竭。

（4）血液系统：如贫血。

（5）泌尿生殖系统：如慢性肾衰竭。

（6）神经精神系统：如痴呆、焦虑症或抑郁症。

（7）呼吸系统：如肺纤维化。

（8）药物性消瘦：二甲双胍、泻药、苯丙胺、氨茶碱、对氨基水杨酸钠、甲状腺激素类药物、雌激素、抗生素、左旋多巴等。

（9）肿瘤性疾病：各系统恶性肿瘤，如胃癌、肺癌、淋巴瘤等。体重减轻可能是其主要症状，也可有其特有的临床表现。

3. 其他　遗传性疾病如苯丙酮尿症、半乳糖代谢缺陷所致精神亢奋、皮肤干燥、生长发育迟缓；创伤、口腔溃疡、牙病、大手术后等不能进食所致的营养物质缺乏等。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者，男性，65 岁，因“消瘦 7 个月”至全科门诊就诊。通过进一步采集病史，了解到以下情况。

现病史：患者于 7 个月前无明显诱因出现消瘦，体重下降 5kg，伴多食、口干、多饮、多尿，每日饮水量 2 500~3 000ml，排尿次数增多，每次尿量不详，无怕热、多汗及易怒，无腹痛、腹泻，无恶心、呕吐，无呕血、黑便或血便，无吞咽困难，无咯血，无发热、盗汗、乏力，无面色潮红及心悸。起初未在意，因邻居近期患癌，担心自身健康问题，遂就诊。自发病以来，精神紧张，睡眠欠佳，每天解 1 次成形黄色软便。

既往史：高血压病史 10 年，规律服用硝苯地平控释片 30mg，每日 1 次，收缩压波动在 110~130mmHg 之间，舒张压波动在 60~86mmHg 之间。否认糖尿病、甲状腺功能亢进症、炎症性肠病、肿瘤等慢性疾病史。否认结核、肝炎等传染病史。无外伤、手术史。无药物和食物过敏史。

个人史：吸烟 40 余年，每日 1 包，无饮酒史。喜食油腻食物，偶尔饭后散步。出生、居住在本地，未到过疫区。家庭成员之间关系和睦。经济收入稳定，高中文化，治疗依从性好。

婚育史：25 岁结婚，育有 1 子，配偶及孩子均体健。

家族史：患者母亲患胃癌，已故。否认家族其他遗传性疾病史，否认家族传染性疾病史。

【问题 2】该患者的病例特点是什么？

思路：该病例特点为：老年男性，因消瘦 7 个月就诊。患者 7 个月体重下降 5kg，伴多饮、多食、多尿。根据糖尿病的典型“三多一少”症状，初步考虑糖尿病，2 型可能性大。

知识点

糖尿病（diabetes mellitus，DM）

根据 1999 年 WHO 糖尿病专家委员会报告，糖尿病的诊断标准是：糖尿病症状加空腹血糖（FPG）≥7.0mmol/L 或随机血糖≥11.1mmol/L 或 OGTT 2 小时血糖（2hPG）≥11.1mmol/L；若患者无典型“三多一少”症状，则需再测一次血糖予以证实。

诊断糖尿病后，必须排除 1 型糖尿病、某些特殊类型糖尿病、妊娠期糖尿病，方能诊断 2 型糖尿病。

由于不同分型的 DM，其治疗方案略有区别，因此，一般须进一步行 C 肽、胰岛素及其自身抗体检测明确其类型。

2 型糖尿病的临床特点：可发生在任何年龄，但常在 40 岁以后发病，多起病隐匿，症状较轻，半数以上可无任何症状；常有家族史；很少发生自发性糖尿病酮症酸中毒。

2 型糖尿病诊断后，还需要判定有无并发症（及严重程度）、是否伴有发病或加重糖尿病的因素。DM 并发症包括急性并发症和慢性并发症。常见急性并发症有低血糖、糖尿病酮症酸中毒、高渗高血糖综合征、乳酸酸中毒、感染；慢性并发症有微血管（糖尿病肾病、糖尿病性视网膜病变、糖尿病心肌病）并发症、动脉粥样硬化性心血管疾病、神经系统（中枢神经系统、周围神经病变、自主神经病变）并发症、糖尿病足等。

【问题 3】消瘦除代谢性疾病原因，还需要注意与哪些疾病鉴别？

思路：消瘦最常见的原因之一是心理因素，尤其是近期压力过大、焦虑与抑郁。消瘦还见于慢性心力衰竭、恶性肿瘤、慢性感染、痴呆所致的生活不能自理的老年人、甲状腺功能亢进症、神经性厌食、神经性贪食等；如有肿瘤家族史，同时需要注意排除恶性肿瘤所致的消瘦，如胰腺癌、胃癌、肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等；还有一些在全科诊疗中较为常见或罕见，同时也容易漏诊的疾病，如药物依赖、慢性肾衰竭、结缔组织病、乳糜泻等吸收不良状态，慢性肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退症等。

知识点

部分全科诊疗中容易被忽略疾病的鉴别

一、药物依赖

常见的药物包括地高辛、非甾体抗炎药、阿片类药物、细胞毒性药物、茶碱、二甲双胍、胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂、利尿剂、抗生素等，还包括不适当使用甲状腺素、泻药以及酒精依赖。任何可引起神经性厌食的药物均可造成消瘦，病史采集需要详细询问患者服药史。

二、慢性肾衰竭

是在各种慢性肾脏病基础上缓慢出现的肾功能进行性减退直至衰竭的临床综合征。以肾小球滤过率降低、代谢产物潴留、水电解质与酸碱失衡为主要临床表现，血肌酐、尿素氮升高。

三、结缔组织病

活动期可出现消瘦，但同时常有关节肿痛、皮肤黏膜损害、雷诺现象、发热、乏力或相关脏器受累表现，血清学抗 ENA 抗体大于或等于 1∶ 10 000，抗 U1RNP 抗体（+），抗 Sm 抗体（–）。

四、乳糜泻

通常因为营养吸收不良与腹泻而消瘦，也有许多患者无消瘦，反而超重，但均存在微量元素缺乏。血清抗体检查和小肠活组织病理检查是诊断的重要手段。

五、慢性肾上腺皮质功能减退症

所有不能解释的腹泻、呕吐、虚弱、低血压，均须注意此病可能，消瘦也是其非特异性症状之一。如出现色素沉着、高血钾、低血钠、酸中毒与低血糖症状，则此病的可能性更大。促肾上腺皮

质激素（ACTH）兴奋试验提示：对 ACTH 无反应。

六、腺垂体功能减退症

起病隐匿，主要表现为甲状腺、肾上腺、性腺等靶器官功能减退的症状，且临床表现取决于垂体激素缺乏的种类、程度、速度与靶腺的萎缩程度。腺垂体功能试验和靶腺激素水平可协助诊断。

【问题 4】完成病史采集后，下一步应重点完成哪些体格检查？

思路：须测量身高、体重、BMI，检查皮肤皱褶处皮肤弹性、皮肤黏膜有无苍白或黄染、甲状腺、浅表淋巴结等。此外，对于患者描述的伴随症状也须重点查体。

知识点

针对消瘦应进行的查体

由于消瘦可能来源于全身各系统疾病，因此，消瘦的查体应全面细致。

如甲状腺功能亢进症应观察有无突眼、甲状腺肿大、双手震颤、心动过速等。

肿瘤性疾病应观察患者有无淋巴结肿大、腹部包块等。

心力衰竭应重点检查心肺、有无颈静脉怒张等。

慢性阻塞性肺疾病应重点检查肺部、有无杵状指等。

肝胆疾病应观察患者有无皮肤黏膜黄染、肝掌、蜘蛛痣、肝脾大、腹水征等。

口腔疾病应重点观察患者口腔黏膜、牙齿、牙龈情况。

腺垂体功能减退症应观察患者有无精神萎靡、毛发稀疏、血压偏低、心动过缓、第二性征消失等。

慢性肾上腺皮质功能减退症应观察患者有无皮肤黏膜色素沉着等。

自身免疫性疾病应观察患者有无皮疹等。

临床病例（续）

客观资料（O）：体温 36.3℃，脉搏 80 次/分，呼吸 18 次/分，血压 128/80mmHg，身高 160cm，体重 55kg，体重指数（BMI）21.5kg/m^2，腰围 75cm，神志清楚，面容正常，表情自然，精神疲倦，自主体位，全身皮肤黏膜无色素沉着、皮疹，无黄染、苍白，未见肝掌、蜘蛛痣，双上臂内侧皮肤弹性差，浅表淋巴结未触及肿大。毛发无稀疏，双眼视力正常，无突眼，口腔黏膜及牙龈光洁、呈粉红色，无龋齿、义齿。甲状腺无肿大。双肺听诊呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率 80 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹部平坦，质软，全腹无压痛及反跳痛，未触及包块，肝、脾肋下未触及，墨菲（Murphy）征阴性，移动性浊音阴性，肠鸣音 5 次/分。双足背动脉搏动对称，无减弱。

【问题 5】结合上述客观资料，为明确诊断应进一步完善哪些检查？

思路：该患者为老年男性，结合其临床表现、体格检查，考虑糖尿病可能，须完善静脉随机血糖或空腹血糖。此外，患者为老年，免疫功能存在不同程度的减退，免疫力相对较弱，行血常规检查协助排除感染；肝肾功能协助排除肝肾疾病；甲状腺功能协助排除甲状腺功能亢进症等。

知识点

消瘦需要完善的辅助检查

一、实验室检查

1. 三大常规检查　血常规作为感染性或血液系统疾病的辅助诊断；尿常规中白细胞、尿蛋白、尿糖协助了解有无泌尿系感染、肾脏疾病、糖尿病；便常规加隐血试验了解有无消化道肿瘤、

炎症性肠病、肠道寄生虫可能。

2. 血生化检查　考虑肝胆疾病须做肝功能检查；肾功能协助排除是否为慢性肾衰竭所致消瘦；考虑糖尿病，行静脉血浆葡萄糖检测；低血脂，注意有无肝脏疾病、甲状腺功能亢进症、慢性肾上腺皮质功能减退症、营养不良、恶性肿瘤等疾病可能；怀疑甲状腺功能亢进症或慢性肾上腺皮质功能减退症须检测甲状腺激素或皮质醇等相应激素水平。

3. 免疫检查　怀疑心力衰竭查脑钠肽；怀疑胰腺癌查糖类抗原 19-9；怀疑肝癌查甲胎蛋白；怀疑胃肠道肿瘤查癌胚抗原等。肿瘤标志物升高，须考虑恶性肿瘤性疾病。血沉特异性较差，但如血沉正常，可排除感染（如结核等）、活动性风湿免疫系统疾病。超敏 C 反应蛋白、降钙素原等可以帮助判断感染严重程度，以及判断消瘦是否与严重感染相关。传染病筛查可以用于诊断慢性乙型病毒性肝炎、HIV 感染等。

二、影像学检查

1. 超声检查　心脏彩超可判断是否存在心功能不全、有无心脏瓣膜赘生物；腹部 B 超可帮助了解有无肝、胆、胰等疾病，如慢性、感染性疾病或肿瘤等。

2. 影像学检查　X 线胸片可用于了解有无感染、肺结核、肿瘤和胸腔积液等；X 线钡餐或钡剂灌肠检查，可发现消化道溃疡、肿瘤或梗阻；胸、腹部 CT 对胸部、腹部肿瘤可明确部位，协助了解其性质；肝脏 CT 或 MRI 可协助明确肝硬化及肝癌。

3. 内镜检查　可进行胃镜、十二指肠镜、结肠镜、小肠镜、腹腔镜、胆道镜等检查，直接观察消化道内腔，包括炎症、溃疡、出血、肿瘤等病变；内镜逆行胰胆管造影、经皮肝穿刺胆管造影术检查有助于胆道和胰腺病变的诊断；膀胱镜可用于协助诊断膀胱炎症、结石与肿瘤；腹腔镜则对腹腔炎症、肿瘤或粘连等有较高诊断价值；纤维支气管镜检查可协助诊断呼吸系统肿瘤。

三、其他检查

1. 血、尿、便细菌培养　怀疑感染者，可行相关细菌学检查协助判断感染原与部位。

2. 骨髓检查和/或淋巴结活检　怀疑血液系统疾病，尤其是考虑恶性肿瘤者，须行此检查。

3. 心理评估　对有精神心理症状患者，可进行心理评估。主要包括焦虑及抑郁评估，采用焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）。评价标准：40~49 分以上为焦虑/抑郁状态可能；50~59 分为轻度焦虑/抑郁，60~69 分为中度焦虑/抑郁，70 分及以上为重度焦虑/抑郁。

临床病例（续）

客观资料（O）：血常规、肝功能、肾功能、甲状腺功能均未见异常；空腹静脉血浆葡萄糖 11.2mmol/L。

【问题 6】该患者在基层应如何评估和处置？

思路：全科医疗中基层评估是根据就诊者的主观资料与客观资料作出初步诊断和健康问题评估。根据病史、体格检查和辅助检查结果，该患者初步评估（A）如下：患者诊断为糖尿病，初诊糖尿病患者分型不明确，且须行 24 小时尿蛋白或尿白蛋白/肌酐比值测定、心脏彩超、头颅 CT 平扫、眼底检查等了解有无并发症。因此，须转诊至综合医院专科就诊。

临床病例（续）

处置计划（P）：

1. 诊查计划　①行甲状腺功能检查，排除甲状腺功能亢进症；②肿瘤标志物检查，协助排除恶性肿瘤可能性；③糖尿病自身抗体检测，可作为糖尿病分型指标之一；④血浆胰岛素与 C 肽释放试验，可用于评估胰岛 β 细胞功能、协助糖尿病分型、病情程度判断及指导治疗；⑤糖化血红蛋白（HbA1c）

检测，帮助了解患者近 2~3 个月的血糖控制水平，是临床决定是否调整治疗方案的依据；⑥行血酮体、电解质、血浆渗透压等检测，了解是否合并糖尿病急性并发症；⑦心电图、心脏彩超、双侧颈动脉彩超、头颅 CT 平扫、尿白蛋白/肌酐比值测定、眼底检查等了解有无糖尿病靶器官损害。

2. 治疗计划　①健康教育；②糖尿病饮食；③运动干预；④保持心态平和；⑤自我监测；⑥药物治疗。

【问题 7】消瘦的转诊指征包括哪些？

1. 任何不能解释的消瘦，尤其怀疑内分泌疾病或恶性肿瘤时。
2. 病情复杂，诊断困难。
3. 须行胃肠镜等检查者。
4. 严重进食障碍疾患。
5. 严重心理障碍、抑郁与精神疾病。
6. 心、肝、肾等重要脏器功能严重受损。
7. 治疗效果差。

【问题 8】针对消瘦患者（以糖尿病为例），全科医师应该如何进行患者教育？

思路 1：让患者知晓消瘦的病因或诱因、何时需要立即就诊。针对该患者应进行糖尿病健康宣教，内容包括什么是糖尿病、糖尿病的危害，尤其应提醒患者警惕低血糖的发生，知晓低血糖的临床表现，若发生低血糖如何进行处理，以及如何进行自我管理等。

思路 2：告知患者生活方式应关注的事项。对于消瘦病因不明患者，鼓励其少食多餐，主动进食，补充维生素与营养丰富的食物，避免进食过量的刺激性食物。病因明确者，针对原发病予以生活方式指导。

对该患者应进行糖尿病饮食教育：合理饮食、吃动平衡，主食定量、粗细搭配，多吃蔬菜、水果适配，常吃鱼禽、蛋类适量，奶类豆类天天要有，少油低盐、足量饮水，定时定量、细嚼慢咽。运动促进总热量消耗、增强胰岛素敏感性、改善胰岛素抵抗，所以糖尿病患者应适当运动。每次运动 30 分钟以上，每周至少 5 次，以有氧运动为主。但须注意，如果血糖 <3.9mmol/L 或 >16.7mmol/L，应停止运动、立即就诊。关注糖尿病患者的心理状态，鼓励其积极配合治疗，避免紧张，保持心情舒畅。戒烟限酒。

思路 3：规律药物治疗，预防并发症的发生与发展；重视对血糖的监测，定期随访复查 HbA1c 等辅助检查项目，以便适时调整治疗方案，避免并发症发生或对并发症早发现、早诊断、早治疗，提高生存质量。

（顾申红）

思考题

1. 消瘦的定义是什么？
2. 消瘦按发病机制的分类有哪些？
3. 简述在全科诊疗中容易被忽略的引起消瘦的疾病。
4. 消瘦的转诊指征有哪些？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES